

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

신바로건조엑스 300mg (신바로캡슐, (주)녹십자)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 신바로건조엑스 300mg/캡슐

☐ 효능 효과 :

소염, 진통, 골관절증

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2011년 제7차 약제급여평가위원회 : 2011년 5월 19일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일: 2011년 5월 2일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘소염, 진통, 골관절증’에 허가받은 약제로, 대체약제 중 celecoxib와의 직접비교 임상시험 결과 효과 등에서 비열등하였으며, 국내개발 천연물 신약에 해당하고 향후 유사 약제인 조인스정의 급여기준 설정 시 신청품도 함께 검토될 예정임을 고려 시 비용 효과성이 수용 가능하므로¹⁾ 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “소염, 진통, 골관절증”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 급여 가능한 다수의 NSAIDs(aceclofenac, meloxicam, loxoprofen 등) 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 예로부터 골다공증, 관절염, 디스크 등의 치료에 사용되던 ‘추나약물(양근탕, 청파전 등 자생한방병원 고유 처방)’을 바탕으로 한 국내개발 천연물 신약으로, 제약사에 의하면 염증매개인자(iNOS, Cox-2, TNF- α 등) 유전자 발현억제, MMP-2,9 활성 억제, pain substance 유리억제, ALP 활성 증가의 약리작용을 나타냄.
- 교과서²⁾³⁾ 및 임상 진료 지침⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 골관절염에 추천되는 약제는 아세트아미노펜, 국소 캡사이신, NSAIDs, Cox-2 억제제, 관절강 내 주사(히알루론산, 스테로이드), 마약성 진통제 등이 있으며, 신청품은 교과서 및 가이드라인 등에 수재되어 있지 않음.
- 슬관절 골관절염 환자에 대한 3상 RCT 결과 신청품은 celecoxib와 비교하여 효과 및 안전성 면에서 비열등하였음.⁷⁾
 - WOMAC scale 총점 변화량(1차 평가변수)은 시험군 ■■■점 대조군 ■■■점으로 군간 유의한 차이는 없음($p=■■■$).
 - 이상약물반응은 총 ■■■명(■■■%)에게서 ■■■건이 발생함. 신청품군은 ■■■명(■■■%, ■■■건), celecoxib ■■■명(■■■%, ■■■건)으로 치료군간 통계적으로 유의한 차이 없음($p=■■■$).

○ 비용 효과성

- 신청품은 ‘소염, 진통, 골관절증’에 허가받은 약제이고, 교과서⁸⁾⁹⁾ 및 임상진료지

침¹⁰⁾11)12)에 따르면 아세트아미노펜 투여로 조절이 되지 않는 경우 환자 상태에 따라 NSAIDs, Cox-2 억제제를 선택하도록 되어 있으며, celecoxib와의 효과 등에서 비열 등한 점 등을 고려하여 NSAIDs와 Cox-2 억제제가 대체가능함. 다만, 대체 가능한 성분이 다수임을 고려하여 누적 청구량¹³⁾ 상위 80%에 해당하는 성분을 선정 시 meloxicam, aceclofenac, celecoxib, nabumetone, 조인스정, loxoprofen, talniflumate가 대체약제에 해당함.

- 신청품의 일일 투약비용(■■■■원/일)은 ■■■■ 대비 저가임.

- 다만, 기존 NSAIDs와 병용투여 시¹⁴⁾ 신청품의 투약비용은 더 증가할 가능성이 있음.

○ 재정 영향¹⁵⁾

- 대상 환자수¹⁶⁾는 연간 약 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차 년도에 ■■■■원, 3차 년도에 약 ■■■■원이 되고, meloxicam, aceclofenac, celecoxib, nabumetone, 조인스정, loxoprofen, talniflumate의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원 증가 될 것으로 예상됨¹⁹⁾.

- 다만, 기존 NSAIDs와 병용투여 시²⁰⁾ 신청품의 투약비용은 더 증가할 가능성이 있음.

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가에 등재되어있지 않음.

Reference

- 1) ■■■■
- 2) Pharmacotherapy -A Pathophysiologic Approach, Chapter.95 Osteoarthritis
- 3) Harrison's Internal Medicine 17th, Chapter.326 Osteoarthritis
- 4) OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II (Osteoarthritis Research Society International, 2008)
- 5) Recommendation for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee(American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines, 2000)
- 6) Treatment of Osteoarthritis of the Knee Full Guideline(American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2008)
- 7) 제약사 제출 3상 임상 자료
- 8) Pharmacotherapy -A Pathophysiologic Approach, Chapter.95 Osteoarthritis
- 9) Harrison's Internal Medicine 17th, Chapter.326 Osteoarthritis
- 10) OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II (Osteoarthritis Research Society International, 2008)

- 11) Recommendation for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee(American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines, 2000)
- 12) Treatment of Osteoarthritis of the Knee Full Guideline(American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2008)
- 13) M13: 기타 관절염, M14: 달리 분류된 기타 질환에서의 관절병증, M15: 다발성 관절증, M16: 엉덩관절증, M17: 무릎관절증, M19: 기타 관절증, 심평원 골관절염 약제평가 시 상병 기준
- 14) 대한정형외과학회()
- 15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16) 08-10년 골관절증 상병(M.13-17, M.19, 약제평가 기준 상병)의 환자수를 가중이동평균법을 이용하여 추정
- 17) 제약사제출 예상사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
사용량(캡슐)			

- 18) 절대재정소요금액=제약사 제시 예상 사용량 X 신청 약가
- 19) 재정증감액=(신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제시 예상사용량
직전년도의 대체약제 간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 20) 대한정형외과학회()